4

Psicopatología de las conductas de adormecimiento y sueño

I. Generalidades

La clínica de los trastornos del sueño en el niño es muy variada en todas las edades. No obstante, hay que señalar la extrema importancia de las perturbaciones precoces. Como en toda conducta perturbada, la significación del trastorno del sueño no es unívoca: depende de la naturaleza misma de tal trastorno, de su intensidad, de los signos asociados, de la edad del niño y de su evolución. En los últimos años se ha atendido de forma especial a los trastornos graves del sueño de los bebés. Su presencia indica, a menudo, una profunda perturbación en los primeros rudimentos de la organización de la personalidad.

Después de la introducción y amplia utilización de los registros electroencefalográficos, el estudio de los trastornos del sueño ha sido totalmente renovado. Es éste un campo privilegiado de fructuosa confrontación entre investigadores procedentes de disciplinas distintas, tradicionalmente divergentes.

A. EL SUEÑO: ASPECTO ELECTROFISIOLÓGICO

La llegada de la electroencefalografía ha transformado profundamente los viejos conocimientos sobre el sueño infantil, reducidos hasta entonces a una vaga estimación cuantitativa. El registro prolongado del EEG nocturno ha puesto en evidencia la similitud morfológica de los diversos estadios del sueño observados en el adulto o en el niño, y también las diferencias existentes en el reparto cuantitativo de dichos estadios.

Es un hecho conocido que las características del sueño evolucionan muy rápidamente a partir de los primeros meses de vida. Recor-

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito

demos brevemente las principales fases del sueño descritas a partir de los registros eléctricos. El sueño se divide en dos grandes fases:

■ **Fase de sueño paradójico (SP);** es paradójica puesto que el EEG es parecido a un EEG en estado de vigilia, mientras que el umbral de estimulación del despertar es muy elevado. Se la llama también fase de movimiento ocular (FMO, rapid eye movement, REM), o también fase de sueño rápido. En ella se constata:

1. Actividad eléctrica rápida, poco diferenciada de la que existe en estado de vigilia.
2. Existencia de movimientos oculares rápidos.
3. Relajación del tono muscular en el adulto, o en el niño, a partir de los 2 años, mientras que en el recién nacido se aprecia la existencia de pequeños movimientos de las extremidades o de la cara, a veces del eje corporal, así como inhibición de la actividad tónica de la barbilla.

■ **Fase de sueño tranquilo o lento,** desprovista de actividad motriz, con ondas lentas en el EEG. Dicha fase se subdivide a su vez en estadios I, II, III y IV, según el ritmo y la amplitud de las ondas eléctricas, yendo desde el sueño ligero (estadio I) al sueño profundo (estadio IV).

En el transcurso del sueño se observa la alternancia periódica de estas fases: el SP sucede habitualmente a una fase de sueño lento y profundo. El significado de ambos tipos de sueño será también diferente. El sueño lento va acompañado de reparación energética o de síntesis proteica (en el transcurso del sueño lento, la hormona de crecimiento presenta un incremento secretor), mientras que el SP corresponderá a la experiencia del soñar (v. pág. 85).

B. DISTINCIÓN ENTRE EL SUEÑO DEL ADULTO Y EL DEL NIÑO

En el sueño del adulto existen cuatro particularidades que lo distinguen del sueño del niño:

1. Valor cuantitativo

El recién nacido duerme por *término medio* de 16 a 17 horas por día en fracciones de 3 horas, repartidas entre el día y la noche. A la edad de 3 meses, duerme cada día 15 horas, pero con un ritmo diferente, con fases más prolongadas durante la noche (hasta 7 horas seguidas) y largos ratos de vigilia durante el día. El sueño diurno (la siesta) desaparece hacia los 4 años y la cantidad de sueño total disminuye *enseguida progresivamente*: 13 horas hacia el año, 12.30 h entre 3 y 5 años, 9.30 h entre 6 y 12 años, 8.30 h entre 13 y 15 años. Existen, no obstante, grandes variaciones interindividuales; Parmelee distin-

gue, desde el primer día de vida, recién nacidos con sueño corto y otros con sueño largo.

2. Reparto de las fases de sueño

Después del nacimiento, el sueño paradójico ocupa un 50 % del tiempo de sueño. Dicho porcentaje se reduce enseguida progresivamente hasta llegar a un 20 % en la edad adulta. La duración media de un ciclo de sueño (un ciclo es el tiempo que separa dos fases de SP) es de 60 minutos en el niño, en vez de los 90 a 120 minutos que dura en el adulto. El sueño lento se observa principalmente en las primeras 4 horas, mientras que el SP predomina al finalizar la noche.

3. Período inicial del sueño

En el recién nacido y en el niño (antes de los 2 años) se observa una fase de SP precoz, de 30 a 45 minutos después de dormirse. Por el contrario, en el niño mayor, el tiempo que transcurre hasta que aparece el SP es especialmente largo (alrededor de 120 minutos), con una primera fase de sueño paradójico atípico e incompleto. Algunos autores (Braconnier) ven aquí una de las causas de la fragilidad del primer sueño del niño y de los accidentes paroxísticos que sobrevienen entonces, tales como los terrores nocturnos o el sonambulismo.

4. La significación del sueño evoluciona

El sueño, pura necesidad física (alternancia sueño/saciedad y despertar/hambre) en el recién nacido o en el bebé de menos de 3 meses, bajo la acción conjugada de la ritmicidad endógena y de la presión del ambiente, se convierte lentamente en una función relacional fundamental. Volveremos a hablar de ello más adelante.

C. DORMIR Y SOÑAR

1. Correlación electrofisiológica

No hay duda alguna de que el SP corresponde a la actividad soñadora. Los sujetos (niños o adultos) despertados durante una fase de SP recuerdan siempre con precisión un sueño, lo cual no sucede si se les despierta durante el sueño profundo. Se ha observado también correlación entre la intensidad dramática del sueño y la intensidad de las manifestaciones propias del SP (pausas respiratorias, aceleración cardíaca). Finalmente, la experimentación animal nos muestra que la fase SP va acompañada de actividades automáticas cuando se anula la inhibición motriz mediante destrucción de los centros inhibidores (Jouvet).

En el transcurso de la noche se observa la evolución de las fases de S.P. que son más importantes al finalizar ésta, con actividad onírica acentuada y, al parecer, menos ansiógena (Synder).

Sobre la función del soñar y del SP hay varias teorías:

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito

1. Función de maduración según algunos, quienes basan su argumento en la importancia cuantitativa del SP creciente hasta el nacimiento y decreciente después de forma progresiva (Roffwarg).

2. Función de liberación y descarga de las tensiones instintivas (Dement).

3. Función de programación (Jouvet), las huellas mnésicas dejadas por la experiencia diurna se integran, relacionan y programan en el transcurso del SP. En esta última hipótesis, el sueño, en particular el SP, desempeñaría un papel primordial en las capacidades de adaptación entre la dotación genética y la aportación del ambiente. Se hallaría igualmente en la base de las funciones de retención mnésica y de aprendizaje.

2. *Enfoque psicoanalítico y psicogenético*

Después de los trabajos de Freud, el dormir y el soñar ocupan un lugar privilegiado en la teoría psicoanalítica. Sin avanzar equivalencias simplistas y en exceso reductoras entre dos campos de investigación muy heterogéneos, como son el campo electroencefalográfico y el campo psicoanalítico y psicogenético, podemos decir que ciertas hipótesis emitidas en estos terrenos se yuxtaponen, mientras que otras, como veremos, parecen incompatibles.

Según Freud, los sueños son un compromiso entre la «realización de un deseo imaginario inconsciente» y el efecto del descenso de la censura, más tolerante en el transcurso del sueño, asociada además al mantenimiento de la actividad preconsciente que preserva el dormir. Sin referirnos aquí a la actividad de los sueños, es decir, a los mecanismos mentales que preludian la elaboración onírica (figuración, condensación, desplazamiento), el soñar está considerado por Freud como un fenómeno pasivo de descarga de los deseos inconscientes y como «el guardián del sueño». De hecho, permite su continuidad operando sobre la energía instintiva que amenaza al psiquismo con una escisión traumática. Fain y David recuperan el papel del vínculo y mantenimiento de la continuidad desde una perspectiva ligeramente distinta de la de Freud: el sueño constituiría un instrumento al servicio de mecanismos de integración del Yo que permitiría asociar la energía instintiva del Ello con representaciones psíquicas y, en consecuencia, crear esquemas de interacciones de unión del afecto con una representación psíquica, esquemas a partir de los cuales podría vincularse progresivamente la actividad psíquica (Houzel, Braconnier).

Otro punto de vista es el de M. Khan, quien distingue entre «el relato del sueño» y «la experiencia del sueño». El *«sueño bueno es un sueño quegracias a la actividad del sueño conseguido, incorpora un deseo inconsciente y puede así permitir que el dormir prosiga y permanecer disponible a la experiencia psíquica del Yo, una vez la persona ha despertado»*. Por el contrario, «el relato del sueño» es el resultado de un fracaso: el proceso fisiológico del soñar queda horadado por la experiencia que de él posee el sujeto, y no es útil para la elaboración de los conflictos internos. De cualquier forma, el relato del sueño es el resultado de una introyección, mientras que la experiencia del sueño procede de una interiorización (Houzel).

En el niño, además de la evolución de las necesidades cuantitativas en el dormir, la distinción entre relato y experiencia del sueño nos permite abordar el problema de la aparición de la función onírica. La imaginería del sueño es especialmente rica, pero no obtendremos un relato del mismo antes de los 2 o 2 años y medio. Ésta es la razón por la cual L.B. Ams considera que el sueño aparece hacia la edad de 2 años. Otros autores, por el contrario, haciendo hincapié no en el relato, sino en lo que sería una experiencia preverbal, consideran

que la experiencia onírica, como satisfacción alucinatoria de un deseo, sería mucho más precoz. Los diversos organizadores de la vida psíquica definidos por Spitz sirven para describir su evolución (Fain, Kreisler). Ciertamente, tanto a la luz de las investigaciones electroencefalográficas como a través de la observación de la conducta del bebé en el transcurso del dormir, y mediante los descubrimientos de la psicología genética, parece ser que las preformas del sueño se dan ya en el primer año. La naturaleza de los sueños es muy variada: sueño-realización de deseo, reviviscencia de acontecimientos agradables o no, ya transcurridos, sueño del castigo, sueño de angustia y pesadillas. Según el grado de madurez del niño, de su capacidad de expresión y de su propia experiencia, el relato del sueño variará extraordinariamente. La mayoría de los estudios (Foulkes, Zlotowicz, Braconnier) se han llevado a cabo con niños de 6 a 12 años. Por un lado nos muestran la estrecha relación existente entre la vida psíquica en estado de vigilia y la actividad onírica, y por otro la evolución de la actividad onírica en el transcurso de la noche. Los sueños del final de la noche suelen ser más agradables y más ricos tanto en lo que se refiere al vocabulario como a los temas descritos. Son especialmente frecuentes los sueños de angustia; no obstante, algunos autores piensan que «el sueño bueno» suscita una represión tal que es olvidado al despertar; sólo se recuerda la pesadilla, de ahí su aparición frecuente.

La función y el significado del sueño evolucionan con la edad y explican, en parte, alguna conducta patológica. Si en principio la alternancia sueño/vigilia depende estrechamente de la alternancia satisfacción/necesidad, rápidamente la dimensión del deseo, la capacidad de regresión y la naturaleza de la relación con la madre modifican este ritmo binario. Con la maduración psicoafectiva, el sueño y el dormir pueden expresar:

1. Fusión con la madre (buena o mala).
2. Aniquilación, la desaparición o la muerte.
3. Separación, la pérdida o el abandono.
4. Renuncia a la autonomía o al dominio.
5. Amenaza de la emergencia pulsional y del conflicto edípico.

Para dormirse, el niño debe poder reposar y apoyarse en una correcta y fundida imagen protectora madre-niño, aceptar dicha regresión e investirla con una carga libidinal no amenazadora. El papel del medio es justamente el de disponer el aspecto transitorio del dormir (Soulé) a fin de que la regresión sea aceptada y, por tanto, esperada. La frecuencia de las perturbaciones o de las dificultades de los niños para adormecerse constituye la ilustración *a contrario* de la fragilidad de dicha área intermedia del sueño.

La confrontación (Braconnier) entre las teorías psicogenéticas o psicoanalíticas y los datos electroencefalográficos resulta enriquecedora, aun cuando se huya de toda equivalencia simplista. Ciertas hipótesis emitidas por Freud parecen ser poco compatibles con los actuales conocimientos sobre la psicología del sueño. La regularidad recurrente del SP y de la actividad onírica, con los diversos sistemas neurorreguladores de tipo inhibidor que la acompañan, propicia el desencadenamiento pasivo del sueño. Asimismo, el papel de guardián del sueño no corresponde a los resultados de las experiencias de priva-

ción de SP. Parece existir una estrecha relación entre la actividad psíquica vigil y la actividad psíquica onírica. Por el contrario, el papel de descarga de las tensiones instintivas y sobre todo la función de enlace entre un estado afectivo de base y una representación psíquica parecen hallarse concordes en ambos campos de investigación.

II. Estudio clínico

La clínica de los trastornos del sueño es muy rica y variada. Distinguiremos entre los comportamientos vinculados al adormecimiento (insomnio inicial o tardío, rituales al acostarse, fobia de acostarse, etc.) y las conductas patológicas que aparecen en el transcurso del sueño.

Recordemos que el acto de dormirse corresponde a un momento en el que se enfrentan necesidades y/o deseos contradictorios, incluso cuando, como ya hemos visto, los registros eléctricos han permitido descubrir la fragilidad del sueño inicial del niño, marcado por una primera fase de SP incompleta, «defectuosa».

En cuanto a los trastornos surgidos en el transcurso del sueño, *éstos están siempre relacionados* con el SP, sustituyéndolo, dificultándolo o modificándolo (terror nocturno, sonambulismo, enuresis). Dicha relación con el SP nos conduce a preguntarnos sobre la «función psíquica» de conductas, banales en apariencia o juzgadas como benignas, pero que posiblemente representan las primeras trabas al libre desarrollo de la vida imaginativa.

A. PATOLOGÍA DEL ADORMECIMIENTO

1. Insomnio del primer año

Trastorno muy frecuente, de significado diferente según su gravedad. El insomnio precoz refleja siempre una relación inadecuada entre el bebé y su medio.

■ **Insomnio común,** debido con frecuencia a condiciones inadecuadas o mal organizadas (rigidez excesiva en los horarios de comida, exceso en la ración alimentaria, malas condiciones acústicas, etc.), que pueden ser el reflejo de dificultades prematuras de adecuación entre el bebé y la madre. Habitualmente, el insomnio cede organizando debidamente las condiciones desfavorables.

■ **Insomnio precoz severo.** Es algo muy distinto. Puede tratarse de:

1. **Insomnio agitado.** El bebé no cesa de chillar, gritar y agitarse; se calma sólo durante breves momentos de agotamiento y reanuda los gritos de inmediato. En ocasiones, el insomnio va acompañado de movimientos rítmicos, balanceos violentos o conducta autoagresiva.

2. **Insomnio tranquilo.** El niño permanece en su cuna, abiertos los ojos, silencioso tanto de día como de noche. Parece no solicitar ni esperar nada.

Estos insomnios severos son raros, pero el estudio de los antecedentes patológicos de los niños autistas o psicóticos precoces ha puesto de relieve su frecuencia en el curso de la primera infancia de estos niños. Tales insomnios parecen expresar el fracaso en la capacidad de regresión precoz del bebé, especialmente la posibilidad de regresión a una buena imagen de fusión protectora madre-niño, sobre la cual éste pueda reposar (Fain).

Para algunos, el insomnio grave precoz reflejaría el fracaso de la madre en su papel de protectora del sueño del niño. La frecuencia de estados depresivos, de angustias profundas o de neurosis más estructuradas en aquellas madres cuyos hijos presentan trastornos graves del sueño es un argumento a favor de ello, como también lo es su mejoría concomitante con la atenuación de las dificultades de la madre.

Sea cual sea su origen, la existencia de insomnio precoz severo debe llamar la atención del clínico. Se trata de un síntoma inquietante que precisa de una investigación psicodinámica profunda de las interacciones familiares, especialmente madre-hijo, y que requiere con frecuencia la puesta en marcha de una psicoterapia del binomio (A. Doumic).

2. Dificultades en la conciliación del sueño del niño

Mucho más banales, casi forman parte del desarrollo normal de todo niño, en particular entre los 2 y los 5-6 años. A dicha edad, el niño, en plena conquista motriz, acepta con dificultad la regresión que implica el dormir, a la par que la aparición de los primeros sueños angustiantes convierte el dormir en un estado inquietante. El niño no quiere acostarse, instaura rituales diversos, reclama un objeto contrafóbico (luz, objeto transaccional, pulgar), necesita que sus padres le cuenten una historia, etc. El acondicionamiento de esta «área transicional» entre el despertar y el sueño, momento conflictivo, ha de permitir al niño restablecer su sentimiento de omnipotencia y la convicción de que puede controlar a la vez sus pulsiones y dicha regresión (Soulé). Los padres intuyen tal necesidad y buscan cómo crear o favorecer el desarrollo de dicha área intermedia, satisfaciendo su demanda, explicando la historia, quedándose con él el tiempo preciso.

Por el contrario, la mayoría de las dificultades en la conciliación del sueño evidencia el déficit para acondicionar esa área transicional:

1. **Sea por unas condiciones exteriores defectuosas:** ruido, cohabitación en el cuarto de los padres, irregularidad excesiva en el horario, etc.
2. **Sea por una presión externa inadecuada:** rigidez excesiva, oposición a los padres por parte del niño que desea conservar el dominio de la situación o su propia autonomía.
3. **Sea por un estado de ansiedad o de organización conflictiva interna,** que convierten en temible la regresión inducida por el sueño.

Un análisis detenido de los diversos factores y de sus posibles conexiones debe preceder a cualquier enfoque terapéutico, sin olvidar que la simple reorganización del espacio comporta muchas veces la desaparición de los síntomas: dejar de dormir en la habitación de los padres, ofrecer al niño un sitio más calmado y menos inquietante, etc.

Las manifestaciones clínicas son diversas:

■ **Oposición a acostarse:** el niño grita, se levanta una vez acostado y sólo ceja en sus propósitos después de un largo período de lucha con sus padres, cuando está ya «agotado».

■ **Rituales al acostarse:** muy frecuentes entre los 3 y los 5-6 años. El niño exige que su almohada, su juguete, su pañuelo, sus zapatillas, o tal o cual objeto estén colocados de una determinada manera, siempre idéntica. A veces pide un vaso de agua, un dulce, la repetición del cuento, etc. Estas manifestaciones discretamente obsesivas son el reflejo de la tentativa para dominar la angustia suscitada por la ruptura de la relación y la emergencia pulsional en la edad del conflicto edípico.

■ **Fobia a acostarse:** puede quedar reducida a una petición contrafóbica; lo más frecuente es la luz encendida o la puerta abierta. Pero en ocasiones reviste una intensidad tal que el niño es presa del pánico en cuanto nota los síntomas del sueño. Quiere que le den la mano, solicita dormir con sus padres, en su cama, en un sillón. Sólo una vez dormido logran instalarle en su lecho. Aparece, por lo general, después de episodios con sueños de angustia o terrores nocturnos, hacia los 2-3 años.

■ **Insomnio auténtico:** se observa en el niño mayor o en el adolescente. Es mucho más raro. Lo alegan con frecuencia los padres, debido al retraso en conciliar el sueño. En realidad, el registro eléctrico muestra que, en la mayoría de los casos, estos preadolescentes o adolescentes tienen un sueño normal en cantidad y calidad, pero desfasado hacia el final de la noche o el inicio de la madrugada. Duermen

entre las 2 de la madrugada y el mediodía más que entre las 22 y las 8 h. Estos desfases en el ritmo del adolescente son muy frecuentes. Sus causas son diversas: deseo de gobernar totalmente su propia vida, incluyendo su ritmo circadiano; despertar de la ansiedad frente a la intensa actividad pulsional; culpabilidad ante su vida onírica o ante la masturbación, etc. No es extraño que reaparezcan en la adolescencia algunas conductas de adormecimiento propias de la primera infancia, conductas en parte desaparecidas en el curso del período de latencia, rituales al acostarse o fobias frente al sueño. La necesidad de dormirse escuchando música o leyendo hasta horas avanzadas puede compararse a sus equivalentes de acondicionamiento tradicional (Braconnier). El insomnio auténtico, es decir, la reducción real del tiempo de sueño, es raro. A menudo se da en un contexto de crisis de angustia interna y puede preludiar la aparición de un episodio psicótico agudo, tipo «bouffée» delirante aguda.

■ **Fenómenos hipnagógicos:** observados entre los 6 y los 15 años, muy frecuentes en el momento de dormirse (Michaux y Berges). Se han descrito sensaciones cinestésicas (descargas eléctricas, sobresaltos), visuales (imágenes geométricas, personajes o animales más o menos flotantes), y más raramente auditivas. Dado su carácter ansiógeno, estos fenómenos hipnagógicos pueden provocar el despertar del sujeto y dar pie a otras dificultades para conciliar el sueño.

B. PARASOMNIAS

1. Angustias nocturnas

Agruparemos bajo este término las diversas conductas, no siempre diferenciadas con el rigor necesario, dadas las confusiones existentes entre la patología del adulto y la del niño. Se trata de «terrores nocturnos» o *pavor nocturnus*, sueños de angustia y despertares llenos de ansiedad. El término «pesadilla» nos parece equívoco en la medida en que, según los autores, igual designa el terror nocturno (la pesadilla del adulto), como el sueño de angustia, como el simple despertar ansioso. Ciertamente, en todos los casos se trata de un episodio agudo que se interfiere en el sueño; pero el estudio electroencefalográfico permite establecer una distinción rigurosa entre el terror nocturno que sobreviene durante el sueño lento y el sueño de angustia relacionado con la aparición de una fase de SP.

■ **Terror nocturno:** se trata de una conducta alucinatoria nocturna. Bruscamente, el niño grita en su lecho, con expresión aterrorizada en los ojos, trasmudado el rostro. No reconoce ni su entorno ni a su madre, y parece innaccesible a cualquier razonamiento. Habitualmente se observa palidez, sudores y taquicardia. La crisis dura como

mucho algunos minutos. El niño se vuelve a dormir enseguida. Estos terrores nocturnos sobrevienen en los inicios del período edípico (3-4 años) y aparecen en el primer ciclo del sueño. Al día siguiente, es habitual que no recuerde nada de lo acaecido.

Los registros electroencefalográficos durante la noche han permitido precisar que el episodio sobreviene en el transcurso del estadio IV del sueño lento y se caracteriza por la aparición de ondas lentas, monomorfas, como las observadas en la reacción de despertar en onda lenta en el niño (Fischer, Benoit).

Estos episodios afectan entre un 1 y un 3 % de los niños de menos de 15 años, y un 6 % de niños en edad preescolar; en la mayoría de los casos se reproducen algunas veces entre los 3 y los 5-6 años y luego desaparecen. Más raramente se dan de forma regular, prácticamente cotidiana; otros síntomas pueden asociarse a éste, especialmente de naturaleza fóbica.

Desde un punto de vista electrofisiológico, se considera que el terror nocturno –como el sonambulismo– es un estado de vigilia disociada con activación neurovegetativa al mismo tiempo que la corteza probablemente permanece en sueño lento profundo. Representaría una persistencia de las reacciones de despertar inmaduras observadas en el 85 % de los lactantes de entre 1-2 años (Kales).

En el plano psicopatológico, el terror nocturno, cuya aparición coincide con el conflicto edípico, parece ser la expresión de emergencia de una angustia extrema *«no elaborable que afecta al aparato psíquico»* (Houzel). Su aparición intermitente podría considerarse como la traducción de las primeras y torpes tentativas de elaboración frente a las angustias edípicas. Por el contrario, la persistencia de los terrores nocturnos significa generalmente la imposibilidad del niño para elaborar mejores defensas psíquicas y puede señalar el retorno a posiciones preedípicas.

■ **Sueño de angustia:** muy frecuente, el 30 % de los niños (Casou, Feldman) relata un episodio de este tipo acaecido recientemente. Puede observarse desde la edad de 2 años. El niño gime, grita, llora y solicita socorro. En ocasiones se despierta, pero normalmente es al día siguiente cuando explica su «mal sueño».

El sueño de angustia es más frecuente en el inicio de la noche, mientras que los sueños agradables predominarían al finalizar ésta. El porcentaje de sueños de angustia en relación con la totalidad de los sueños ha sido evaluado diversamente, y parece depender de la edad de los niños y de las condiciones en que ha sido recogida la información sobre el sueño (psicoterapia, recogida en el laboratorio, encuesta estadística). Pero en todos los casos el sueño de angustia se corresponde con una fase de SP.

Al igual que el terror nocturno, el sueño de angustia es de poca importancia, sobre todo si sucede después de un acontecimiento traumático. En este caso constituye la evidencia de la progresiva estructura-

ción del aparato psíquico y de la puesta en marcha de los principales mecanismos defensivos (desplazamiento, condensación, etc.). Por el contrario, su repetición regular cada noche y su persistencia más allá del período edípico, o su asociación con otros síntomas, pueden ser signo de organización neurótica o psicótica.

■ **Despertar ansioso:** a medio camino entre el terror nocturno y el sueño de angustia. El niño se despierta, inquieto, pero sin manifestaciones alucinatorias; con frecuencia se va a la cama de los padres para volver a dormirse. Los registros eléctricos muestran que el despertar ansioso se sitúa pronto en el estadio III o IV del sueño lento, al principio de la noche (primer o segundo ciclo del sueño).

2. Sonambulismo

El sonambulismo, con predominancia en los varones, aparece entre los 7 y 12 años en niños que suelen tener antecedentes familiares de sonambulismo. Entre un 6 y un 10 % de los niños de esta edad presenta varios episodios al mes.

En el transcurso de la primera mitad de la noche, el niño se levanta y deambula. En ocasiones muestra una actividad complicada, siempre idéntica. Después de algunos minutos (10 a 30), se vuelve a acostar o se deja conducir hasta el lecho. Al día siguiente, no recuerda nada. En su forma más simple, el niño, con los ojos abiertos, tan sólo intenta levantarse. El 15 % de los niños entre 6 y 12 años ha tenido por lo menos un episodio, pero sólo entre un 1 y un 6 % de ellos presenta un «sonambulismo con riesgo» (De Villard) a causa de la frecuencia de los episodios (2 o 3 veces por semana, o más) o del tipo de actividad, que puede ser molesta o peligrosa (defenestración).

El «sonambulismo terror» es una variante clínica más rara (De Villard), la cual asocia deambulación y manifestación de terror. Cuando se intenta calmarlo o sujetarlo, el niño puede reaccionar agresivamente.

Los registros eléctricos han mostrado que el sonambulismo sobreviene en el inicio de la noche, a menudo en el estadio IV que precede en 10 a 15 minutos a una fase de SP, o bien en el estadio IV que precede al primer esbozo de sueño paradójico. En todos los casos interrumpe el desarrollo de la fase de SP normalmente previsible.

En la mayoría de los niños, el sonambulismo se presenta aislado. Sólo algunos ostentan rasgos neuróticos (ansiedad, fobia), especialmente en la forma de «sonambulismo terror». Además, la interferencia con la fase de SP entorpeciendo su transcurso normal y en consecuencia la posibilidad de una actividad onírica, evoca la hipótesis de un fracaso en las posibilidades de mentalización y de un desplazamiento de la energía pulsional hacia vías de descarga motora (Houzel). Desde este enfoque, existiría una equivalencia entre el terror nocturno, el sonambulismo y la enuresis nocturna, episodios que están relacionados idénticamente con la fase de SP.

MASSON, S.A. Prohibida la reproducción sin autorización de los autores

Tratamiento: es curioso destacar la existencia de un tratamiento específico del sonambulismo, eficaz en la práctica totalidad de los casos. Se trata de la amineptina, 1/2 o 1 comprimido por la noche al acostarse o media hora antes (cuando el acceso de sonambulismo sobreviene poco después de dormirse) durante un mes. Al mes siguiente se disminuye la dosis a la mitad, después se detiene el tratamiento. En caso de sonambulismo terror, se recomienda la amineptina junto con un ansiolítico (De Villard) e idéntica posología.

3. Automatismos motores: ritmias de sueño

Las ritmias de sueño afectan principalmente al niño. De precoz aparición silenciosas al principio, se convierten en motivo de consulta cuando el niño empieza a hacer ruido. El 4% de los niños, más o menos, presenta ritmias (Lacombe).

Clínicamente: aparecen en mitad de la noche, duran algunos segundos y se repiten 3 o 4 veces en el transcurso de la misma. Algunas veces duran de 15 a 30 minutos, su ritmo es extremadamente regular, alrededor de un golpe por segundo. El movimiento en sí varía: giro de la cabeza de derecha a izquierda, balanceo de una pierna o de una rodilla doblada, gran oscilación anteroposterior en posición genopectoral. El movimiento puede alcanzar gran intensidad, producir mucho ruido e incluso comportar el desplazamiento del lecho a través de la habitación. De hecho, el niño regula sus impulsiones de acuerdo con la frecuencia de oscilación del lecho, lo cual provoca un fenómeno de resonancia: esto explica la escasa cantidad de energía consumida realmente.

En el plano eléctrico: las ritmias se observan a menudo en los estadios ligeros del sueño lento y más raramente durante el SP. En todos los casos, el trazado eléctrico del sueño es estrictamente normal. Las ritmias no guardan, pues, relación alguna con la epilepsia nocturna o cualquier otra anomalía del sueño y, en consecuencia, no se justifica ningún tratamiento antiepiléptico.

Evolución: acostumbra darse la desaparición espontánea en la mayoría de los casos, a partir de los 3-4 años. Sólo algunos pocos persisten más allá de dicha edad, pero desaparecen en la pubertad.

El ***enfoque psicopatológico*** ha suscitado poco interés. Los niños no parecen presentar ningún rasgo específico. Por el hecho de sobrevenir en el transcurso del sueño ligero, relacionaríamos las ritmias del sueño con las del adormecerse, análogas en el plano clínico. Evidentemente, la catexis autoerótica del cuerpo y del balanceo se hallan en primer plano. ¿Puede ser éste un modo específico para ciertos niños de acondicionar su área de adormecimiento?

Conducta práctica: sin representar un inconveniente para el sueño del niño en sí, las ritmias pueden, por efecto del ruido, despertar a toda la familia. En este caso, una buena medida consiste en poner el colchón sobre el suelo; evita la resonancia, atenúa el síntoma y suprime el ruido. No son aconsejables los tratamientos médicos, más perjudiciales que útiles.

Mencionaremos también aquí algunos automatismos motores específicos: el bruxismo o rechinar de dientes y la somniloquia, durante la cual el niño murmura o habla indistintamente. Con frecuencia se asocian a otras perturbaciones del sueño. Su relación con las distintas fases del sueño no ha sido estudiada todavía.

4. Enuresis nocturna

Remitimos al lector al capítulo dedicado a los trastornos esfinterianos. Recordemos simplemente que la enuresis nocturna sobreviene un poco antes de la fase de SP y entorpece su desarrollo previsible, lo cual la relaciona con los terrores nocturnos y el sonambulismo.

5. Epilepsia nocturna o epilepsia morfeica

No tiene un carácter clínico específico fuera de su aparición en el transcurso del sueño, con frecuencia en el momento del despertar (v. cap. «Epilepsia»).

C. PATOLOGÍA PARTICULAR

1. Apneas en el curso del sueño

Son raras, pero su estudio es importante puesto que algunos autores han formulado la hipótesis de que la apnea en el transcurso del sueño podría ser la causa de la muerte súbita del bebé.

La apnea durante el sueño puede comportar hipersomnia diurna y despertares nocturnos repetidos, pudiendo llegar hasta el insomnio nocturno. En los casos estudiados (Guilhaume), algunos niños con apneas importantes (más de 15 segundos) presentaban también una notable patología ORL. La amigdalectomía ha disminuido la frecuencia y duración de las apneas. En estos casos, el factor periférico de obstrucción pudiera haber sido el responsable. También se ha emitido la hipótesis de una disfunción central de los centros respiratorios.

2. Hipersomnia

Ante toda hipersomnia o somnolencia, es preciso ante todo descartar cualquier causa neurológica, como encefalitis, hipertensión intracraneana, sea cual sea su origen, traumatismo craneal o una causa metabólica.

Es necesario realizar enseguida la observación de las variaciones psicológicas en la demanda de sueño y en los ritmos nocturnos propios de cada individuo, sea adulto o niño.

Por último, es necesario investigar una deficiente higiene del sueño (niños que se acuestan demasiado tarde, despertar nocturno de repetición por diversas razones, ruido anómalo, etc.).

La hipersomnia patológica rara vez se diagnostica en la infancia. No obstante, la anamnesis de adultos portadores de hipersomnia a menudo pone de manifiesto su inicio en la segunda década de la vida (10-20 años), por lo que el tiempo medio transcurrido hasta llegar al diagnóstico es de 13-14 años. Se distinguen:

Narcolepsia-catalepsia (enfermedad de Gélineau). Su prevalencia fluctúa entre el 0,05 y el 0,067 % (M. Billiard). Este síndrome se caracteriza por:

1. Somnolencia diurna excesiva con accesos de sueño irresistible de varios minutos a algunas horas de duración.
2. Episodios catapléjicos (abolición súbita del tono muscular, que puede durar entre varios segundos y 1 minuto), desencadenados a menudo por emociones, sobre todo de naturaleza agradable.
3. Parálisis del sueño.
4. Alucinaciones hipnagógicas, auditivas, visuales o laberínticas que a menudo asustan al niño.
5. Sueño entrecortado por numerosos despertares.

Los registros poligráficos han puesto de manifiesto que el niño se duerme en sueño profundo sin pasar por el sueño de ondas lentas. Los episodios de cataplejía se consideran una intrusión en estado de vigilia de la inhibición tónica propia del sueño profundo.

El diagnóstico se basa en el análisis clínico, pero asimismo en la «prueba repetitiva de latencia del inicio del sueño». En la tipificación HLA existe un «perfil especial», posiblemente con la presencia de un marcador genético específico (investigación en curso).

Aunque este síndrome se observa a los 15-20 años de edad, con un carácter claramente familiar, no es excepcional comprobar la existencia de uno o dos síntomas en la infancia: los signos más precoces serían hipersomnolencia y episodios de sueño diurno. Estas manifestaciones, bien toleradas hasta los 4-5 años de edad, alteran más tarde la vida social del niño. Entre los antecedentes, se ha destacado la existencia de sonambulismo y un estado hiperactivo (Navelet).

Es recomendable un tratamiento farmacológico que puede ser eficaz en el 60 % de casos.

Unas normas adecuadas de higiene de vida (siestas regulares) mejoran la sintomatología.

La **hipersomnia idiopática** se inicia asimismo a los 10-20 años de edad. Su prevalencia es 4-5 veces inferior a la documentada para la narcolepsia. Este proceso se manifiesta por la asociación de:

1. Sueño nocturno prolongado.
2. Dificultades del despertar.
3. Somnolencia diurna permanente que no mejora con una siesta (al contrario de lo observado en el síndrome de Gélineau).

El registro eléctrico del sueño evidencia un aumento cuantitativo global, con un incremento notable y específico del sueño profundo. El diagnóstico se basa, además de estas características, en la prueba del inicio del sueño repetitivo.

El **síndrome de Kleine-Levin** se caracteriza por la asociación de episodios de hipersomnia con hiperfagia, alteraciones de la conducta, del humor, y afectación de la conducta sexual. Este síndrome, excepcional, se observa en adolescentes (inicio a los 15-20 años). Ocasionalmente, puede constituir una forma de inicio de una psicosis.

BIBLIOGRAFÍA

ANDERS (Th.) : Étude ontogénique du sommeil du nourrisson. *Confrontations psych.. Spécia,* Paris, 1977, *15,* p. 49-80.

BENOIT (O.) : *Physiologie du sommeil.* Masson éd., Paris, 1984.

BRACONNIER (A.), PAILHOUS (E.), MARTIN (M.), BENOIT (O.) : Recherche sur le rêve chez l'enfant : action d'un traceur. *Neuro. psych. de l'enf.,* 1980, *28,* (4-5), p. 167-173.

DEMENT (W.) : *Dormir, rêver.* Seuil, Paris, 1981.

DE VILLARD (R.), DALERY (J.), MAILLET (J.) : Le somnambulisme de l'enfant. *Neuro. psych. de l'enf.,* 1980, *28* (4-5), p. 222-224.

FREUD (S.) : *Le rêve et son interprétation.* Gallimard, Paris, 1925.

FREUD (S.) : *La science des rêves.* P.U.F., Paris, 1950.

HOUZEL (D.) : Rêve et psychopathologie de l'enfant. *Neuro. psych. de l'enf.,* 1980, *28* (4-5), p. 155-164.

HOUZEL (D.), SOULE (M.), KREISLER (L.), BENOIT (D.) : Les troubles du sommeil chez l'enfant. Avec les articles de : Braconnier, Doumic-Girard, Garma, Guilhaume. *Expansion scientifique française,* Paris, 1977.

MAZET (Ph.), BRACONNIER (A.), *Le sommeil de l'enfant et ses troubles,* PUF, Que sais-je ?, Paris, 1986, 2298, 1 vol.

LACOMBE (J.) : Les rythmies du sommeil chez l'enfant. *Neuro. Psych. de l'Enf.,* 1980, *28* (4-5), p. 220-222.

PASSOUANT (P.), BILLIARD (M.) : La narcolepsie. *Rev. prat.,* 1976, *26* (27), p. 1917-1923.

© MASSON

5

Psicopatología de las conductas motoras

La acción no puede ser concebida si no lo es a través de una doble polaridad. Por un lado, la de un cuerpo en movimiento implicado en una acción justificada por su finalidad, y por otro, la de un cuerpo en relación con un medio susceptible de influir sobre dicho movimiento. De esta forma, una conducta motora simple será diferente según el niño esté solo, en presencia de sus padres, de extraños o de su institutriz.

Al hablar de la motricidad en sí nos referiremos, primero, al tono, cuya evolución es fundamental en los primeros meses, y, después, a la melodía cinética que permitirá el encadenamiento en el tiempo y en el espacio de cada momento gestual, es decir, el automatismo del gesto. Pero el hecho esencial es que hay una correspondencia constante entre el tono muscular y la motilidad en sí, que dirige la armonía del gesto, a la par que se produce una correspondencia entre el tono de la madre y el del niño, auténtico «diálogo tónico».

Frenada en sus inicios por la hipertonía fisiológica, la motilidad evoluciona al ritmo de la maduración fisiológica (desaparición de los reflejos primitivos, adquisición de la pinza, etc.), pero también mediante las posibles interacciones con el ambiente, el cual prepara, conduce y orienta el campo evolutivo del niño y le confiere coherencia. A su vez, la adquisición de nuevas habilidades motoras es indisociable de la forma en que el niño se representa y se siente actuar (integración del esquema corporal estático y dinámico) y de la manera como el medio del niño acoge dicha motilidad y acepta las modificaciones que de ella puedan resultar. De esta forma, la motricidad podrá pasar desde la gestualidad de imitación a la actividad operativa, en la que la praxia se convierte en el soporte de una actividad simbólica.

La integridad de las diversas vías motoras (piramidales, extrapiramidales y cerebelosas) constituye evidentemente el requisito de una

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

realización gestual satisfactoria; pero la integración del esquema corporal estático y dinámico y de su relación con el medio, con la dimensión afectiva que esto implica, son también fundamentales. Dentro del ámbito que aquí vamos a considerar, este segundo aspecto se halla a menudo en el origen de las deficiencias motrices que suelen hallarse?

Por el contrario, excluiremos de dicho campo las disfunciones motrices cuyo origen sea la afectación orgánica manifiesta de las vías motoras: secuelas de encefalopatía infantil, de hemiplejía infantil, etc. (v. pág. 269).

I. Trastornos de la lateralización

Motivo frecuente de inquietud para los padres, sobre todo cuando la lateralización parece inclinarse hacia la izquierda. No obstante, antes de favorecer en el niño la utilización preferente de una u otra mano, las deficiencias existentes deben ser exploradas a fondo. La proximidad del aprendizaje de la lectura y de la escritura constituye a menudo el motivo aparente de la consulta, y es entre los 5-6 años cuando se solicita consejo.

Recordemos que a partir de los 3-4 años, aproximadamente, se inicia cierta preferencia lateral y que sobre los 4-5 años existe todavía un 40 % de niños mal lateralizados, que se convierte en un 30 % a los 5-7 años, y que, por tanto, aparte de los diestros y zurdos homogéneos, existirá siempre un cierto número de niños mal lateralizados, sin que ello haya de comportar forzosamente problemas. En la población adulta los porcentajes se reparten de la siguiente forma: zurdos puros, 4 %, diestros puros, 64 % y ambidextros, 32 % (Tzavaras).

El estudio de la lateralidad se lleva a cabo a nivel del ojo, la mano y el pie. Entendemos por lateralidad homogénea una lateralidad dominante idéntica en los tres niveles:

1. El **ojo dominante** será el que permanezca abierto cuando se pide al niño que cierre un ojo, o aquel con el cual el niño mira a través de un tubo, tapando el otro ojo con la mano.
2. La **mano dominante** queda encima de la otra cuando le decimos que cruce los brazos o que ponga los puños cerrados uno bajo el otro.
3. El **pie dominante** es el que *chuta* el balón con más frecuencia o el escogido para saltar a «la pata coja».

No hay que mostrar al niño el gesto a realizar a fin de evitar la posible imitación.

Cuando la lateralidad es homogénea (derecha o izquierda), el problema no se plantea, aun cuando «ser zurdo» puede complicar ciertos gestos cotidianos (escribir, utilizar tijeras, coger un cazo por el mango). No está demostrado que el índice de los trastornos del desarrollo sea muy diferente entre la población de zurdos que entre la de diestros.

Cuando la lateralización no es homogénea, es importante dejar a gusto del niño la elección para las actividades habituales hasta la iniciación del último curso de educación infantil (5 años). En el transcurso de este año, en el que es ya posible el inicio del aprendizaje de la preescritura, no es aconsejable una intervención prematura, pero hacia el final del año escolar debe favorecerse la utilización de la mano derecha, salvo en los casos en que exista una patente diferencia en la habilidad gestual a favor de la mano izquierda. En la mayoría de los niños, la utilización de la mano derecha no plantea problema alguno. Hay que recordar en efecto que el aprendizaje y el entrenamiento intervienen de forma decisiva hasta la edad adulta, a fin de influenciar e incluso modificar la asimetría manual.

Cuando aparecen dificultades motrices (disgrafía, v. más abajo), es preferible ayudar al niño mediante una reeducación grafomotriz o psicomotriz, en sentido amplio, centrada en el dominio y posesión de un buen tono muscular.

Recordemos que en caso de lesiones orgánicas (p. ej., hemiplejía infantil) es preferible siempre favorecer la utilización del lado ileso.

Señalemos finalmente un caso específico y paradójico: la existencia de los que podríamos llamar «falsos zurdos». Son niños lateralizados a la derecha, pero que utilizan la izquierda para las actividades principales (particularmente la escritura). Dicha utilización se lleva a cabo, ya sea en un contexto de oposición al medio, ya sea como identificación con algún miembro de la familia (padre, abuelo, tío, tía, etc.) zurdo a su vez. El temor a producir un «zurdo contrariado» conduce a dejar que el niño se enfrente solo con una elección neurótica y aberrante, fuente de ulteriores dificultades. En un contexto de esta índole, la reeducación psicomotriz o la psicoterapia consistirán ante todo en conseguir que el niño tome conciencia de su natural habilidad con la derecha y se desembarace de su elección patológica.

II. Disgrafía

Un niño disgráfico es un niño cuya calidad de escritura es deficiente, sin déficit neurológico o intelectual que pueda explicar esta deficiencia.

Es difícil hallar la ubicación adecuada de la disgrafía, dadas sus múltiples interferencias con la motricidad como tal, unidas a la relación del niño con su maestro, el lugar que el aprendizaje escolar ocupa en la dinámica familiar, el valor simbólico de lo escrito, el sostenimiento de la pluma con la mano, etc. La escritura, momento significativo y transcripción gráfica del lenguaje, depende por un lado del aprendizaje escolar jerarquizado, y por otro, de una serie de factores individuales de maduración, así como de factores lingüísticos, práxicos y psicosociales, los cuales presiden conjuntamente su realización funcional. No abordaremos aquí la pedagogía de la escritura, simplemente queremos señalar la importancia que debe otorgarse al problema de la vinculación entre lectura y escritura, al valor expresivo de la escritura y, en resumen, a la motricidad gráfica propia del niño. En lo que se refiere a este último punto, parece ser que el efecto de la maduración funcional es más importante que el del aprendizaje, al menos por lo que afecta a la copia de escritura, y esto hasta la edad de 5 años y 9 meses-6 años, más o menos (Auzias). Antes de esta edad, los niños son en su mayoría incapaces de ejecutar copias legibles y de descifrar aquello que han copiado. Por el contrario, una vez adquiridas la madurez motriz y manual, la calidad del aprendizaje se convierte en una variable esencial.

El estudio clínico de la disgrafía señala que con frecuencia va asociada a otros tipos de dificultades. Se han hallado las asociaciones siguientes:

1. *Trastorno de la organización motriz;* debilidad motriz, perturbaciones ligeras de la organización cinética y tónica (dispraxia menor), inestabilidad.
2. *Desorganización espaciotemporal* caracterizada específicamente por los trastornos en la organización secuencial del gesto y del espacio, y por los trastornos del conocimiento, de la representación y de la utilización del cuerpo, sobre todo en lo que se refiere a la orientación espacial.
3. *Trastorno del lenguaje y de la lectura:* véase dislexia y disortografía (pág. 126).
4. *Trastornos afectivos:* ansiedad, febrilidad e inhibición, que pueden dar lugar a la constitución de un auténtico síntoma neurótico en el que la significación simbólica de lo escrito y del lápiz que la mano sujeta son prevalentes. Auténticas conductas fóbicas u obsesivas pueden manifestarse frente a la escritura mediante una disgrafía cuya característica varía con frecuencia (caso de aislarse) según la naturaleza del escrito o la persona a quien éste va dirigido, y que contrasta con una habilidad gestual y manual conservada por otra parte (dibujo).

Estos diversos orígenes pueden reagruparse (o desembocar) en el «esbozo de grafoespasmo infantil», comparable al grafoespasmo del escribiente en el adulto. En este caso se hallan asociados de forma di-

versa ineptitud, paratonía, reacciones catastróficas ante la escritura, dificultades de lateralización o de lectura y actitudes conflictivas de tipo neurótico.

El examen en el momento de la escritura evidencia una crispación importante del brazo entero, paradas forzosas en el transcurso de la misma, fenómenos dolorosos en la mano y en el brazo y sudoración notable. El conjunto implica ciertamente desagrado extremo hacia la escritura.

El enfoque terapéutico está en función del registro de las dificultades asociadas a la disgrafía y del significado de ésta en la organización psíquica del niño: reeducación grafomotriz y psicomotriz cuando predominan los trastornos espaciotemporales y las dificultades motoras, relajación cuando prevalece la distonía y se organiza el «grafoespasmo», evitación del síntoma y en primer lugar psicoterapia cuando las condiciones afectivas son preponderantes y el síntoma parece integrarse en una estructura neurótica.

III. Debilidad motriz

En 1911, Dupré aisló una entidad específica, a la que llamó «debilidad motriz», compuesta por los siguientes factores:

- **Torpeza de la motilidad voluntaria:** gestos burdos, pesados, como trabados, marcha poco grácil. Frente a una tarea o gestualidad precisa, el niño se instala inadecuadamente (inclinado sobre la silla, en desequilibrio, etc.).

- **Sincinesias:** movimientos difusos, que implican grupos musculares no afectados normalmente por un determinado gesto. Debemos distinguir aquí las **sincinesias de imitación,** que suelen difundirse horizontalmente (movimientos de pronosupinación de la marioneta que se difunden de una mano hacia la otra), bastante frecuentes, que desaparecen lentamente en el curso de la evolución, y las **sincinesias tónicas,** que se difunden a menudo a través del eje vertical (movimientos bucofaciales importantes cuando se mueven las manos, y movimientos de los brazos cuando se mueven los miembros inferiores). Éstas sólo se dan en algunos niños y persisten con la edad. Parecen ser mucho más patológicas.

- **Paratonía:** caracterizada por la imposibilidad o dificultad extrema para obtener una relajación muscular activa. Por ejemplo, cuando el niño está frente al examinador, quien sostiene sus manos o antebra-

zos, mantiene éstos en idéntica posición una vez desaparece el soporte, incluso si le pedimos que se relaje. Esta paratonía es una especie de contracción cerúlea que, en algunos casos, puede llegar hasta la catalepsia y constituye un gran impedimento para la adquisición de una motilidad ligera y armoniosa.

Estas manifestaciones pueden ir acompañadas de reflejos algo vivos y de algunos signos mínimos de irritación piramidal. Para Dupré, el origen orgánico de esta debilidad motriz no es dudoso, dado que, según él, deriva de un proceso de detención del desarrollo del sistema piramidal. No debe confundirse con las anomalías lesionales de las vías motoras y con las perturbaciones que acompañan a la deficiencia mental profunda (v. pág. 177).

Una vez descrita, la «debilidad motriz» tuvo una notable y excesiva difusión, puesto que algunos autores no dudaron en etiquetar así diversas perturbaciones, desde la corea a la tartamudez, pasando por los tics, la inestabilidad, la psicopatía, etc. Se reunieron así, bajo un único vocablo, manifestaciones de naturaleza muy diversa y de origen patógeno muy distinto. Pueden imaginarse fácilmente los riesgos de un criterio semejante.

En nuestra época, este concepto debe ser delimitado con mayor rigor todavía. Deben ser excluidos los síntomas neurológicos que expresan una lesión, y reservar dicho término para las deficiencias motrices propias de las afecciones que se manifiestan en el niño, tanto en la torpeza para «estar en su cuerpo» como para ocupar el espacio y moverse en él con una motilidad intencional y simbolizada suficientemente fluida. La «debilidad motriz» como síntoma se encuentra también en los niños de emotividad lábil, con frecuentes pero discretas perturbaciones del esquema corporal y una vida imaginativa dominada, a menudo, por la mediocre distinción entre el Yo y su medio. En otros puede quedar reducida a una torpeza gestual cuyo significado neurótico es evidente cuando dicha torpeza va unida a un ambiente o persona específicos.

IV. Dispraxias en el niño

No hay límites precisos entre la debilidad motriz grave y lo que suele llamarse dispraxias infantiles. Estas últimas se caracterizan por profundas perturbaciones en la organización del esquema corporal y en la representación témporo-espacial.

En el plano clínico, se trata de niños que son incapaces de llevar a término determinadas secuencias gestuales o que las realizan con ex-

trema torpeza. Vestirse, anudarse los zapatos, abrocharse la camisa, ir en bicicleta sin ruedecitas cumplidos los 6-7 años, etc. Sus dificultades son todavía mayores si deben realizar secuencias rítmicas (p. ej., golpear alternativamente las manos y después las rodillas) o actividades gráficas (disgrafía mayor, mediocridad en el dibujo del muñeco). El fracaso es frecuentísimo cuando se trata de operaciones espaciales o logicomatemáticas. Las pruebas como el test de Bender o la figura de Rey objetivan esta deficiencia. Todo ello conduce a un fracaso escolar global, fracaso en gran medida reactivo ante los trastornos iniciales.

En cambio, el lenguaje, aun cuando no sea estrictamente correcto, se halla proporcionalmente mucho menos perturbado.

La exploración neurológica es casi siempre normal. Las pruebas de imitación de gestos, de designación de las diversas partes del cuerpo, suponen un fracaso total o al menos parcial.

En el plano afectivo, podemos distinguir dos grupos de niños. Unos presentan ante todo dificultades motrices, sin rasgos psicopatológicos sobresalientes. Hallamos ciertamente inmadurez, actitudes infantiles o inhibición en los contactos posiblemente reactiva, dado que el niño dispráxico acostumbra ser blanco de burlas y el hazmerreír de sus congéneres, pero todo ello se mantiene dentro del marco de un desarrollo psicoafectivo sensiblemente normal. Los del otro grupo manifiestan unas perturbaciones más profundas en la organización de la personalidad, que se traducen en el plano clínico por su aspecto extraño, dificultades de contacto y un relativo aislamiento del grupo infantil. Los tests de personalidad revelan una vida imaginativa invadida por temas arcaicos. La pregunta a formular sería si existe en este tipo de niños una organización prepsicótica o psicótica.

El enfoque terapéutico deberá estar en función de la gravedad de los trastornos asociados de la personalidad. La terapia psicomotriz y la ayuda pedagógica resultan aconsejables e incluso indispensables. A menudo se precisa psicoterapia.

V. Inestabilidad psicomotriz

La «inestabilidad» constituye uno de los grandes motivos de consulta en paidopsiquiatría. Se trata, generalmente, de niños (60 al 80 % de los casos). Dicha consulta procede a menudo de la familia, sobre todo si se trata de niños en edad preescolar entre 3-4 y 6-7 años: «no para», «no está quieto», «todo lo toca», «no escucha», «me saca de quicio», son los datos esenciales de la letanía familiar. Otras veces, ya en edad escolar, entre los 6 y los 10-12 años, es el maestro quien plantea el problema a los padres centrando sus quejas sobre la inestabilidad

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es delito

de la atención más que sobre la conducta. Así, «no se concentra en nada», «está en las nubes», «siempre tiene la cabeza en otro sitio», «podría hacer mucho más si atendiera», etc. Estos dos tipos de quejas revelan los dos polos de la inestabilidad, el motor y el de la capacidad de atención.

No obstante, es preciso delimitar el cuadro de la inestabilidad y recordar la existencia de un período en el niño de 2-3 años, o incluso mayor, en el que su atención es naturalmente lábil y en el que su explosiva motricidad le empuja a multiplicar sus descubrimientos y experiencias. No siempre el entorno acepta con facilidad esta conducta, poco tolerada por varias razones (actitud rígida de los padres, exigüidad del espacio, exigencia aberrante de la escuela). Esto es tanto más importante cuanto que se corre el riesgo, frente a la intolerancia del medio y sus inaccesibles exigencias, de que el niño acentúe su conducta y se instale en una auténtica inestabilidad reactiva. Debemos decir al respecto que la vida urbana actual no está en absoluto adaptada a la necesidad de catarsis motora del niño, y da muestras de gran intolerancia frente a lo que con excesiva facilidad se conceptúa de «inestabilidad» patológica. Citemos, entre otros, los ritmos escolares, la frecuente exigüidad de las viviendas, la ausencia de espacios verdes o áreas de descanso, etc.

■ **En el plano clínico,** es conveniente distinguir entre la *inestabilidad motriz* propiamente dicha, en la que el niño no cesa en su movimiento (corre hacia aquí y hacia allá, cruza y entrecruza piernas y brazos mientras está sentado, etc.) y la *inatención o inestabilidad psíquica.* Si con frecuencia se asocian ambas formas en algunos niños, una de las dos puede ocupar el primer plano. La exploración somática es normal.

El **análisis psicomotor** evidencia, además de la inestabilidad motriz, una inestabilidad postural y la existencia de la *«reacción de prestancia»* (Wallon): actitudes afectadas y adultomorfas.

El **estudio del tono** permite, según algunos autores (Berges), distinguir una inestabilidad con paratonía caracterizada por un fondo permanente de contracturas o de tensión, en la que la inestabilidad aparece como una «fuga» en relación con dicho estado de control, y una inestabilidad en la que el equilibrio tónico es normal pero, por el contrario, con numerosos signos de emotividad intensa, incluso caótica: mirada inquieta, sobresalto evidente ante la menor sorpresa, temblor de manos, sonrojo, etc. Son niños que parecen estar permanentemente en un estado de ansiosa hipervigilancia, como si en todo momento el entorno pudiera resultar peligroso o desmoralizador.

■ El **contexto psicológico** varía. Ante todo, la inestabilidad puede integrarse dentro del cuadro de un estado reactivo a una situación traumatizante o ansiógena para el niño. Recordemos que cuanto menor es éste, más tiende a expresar el malestar o la tensión psíquica

mediante su cuerpo. Actuar es en un principio la modalidad más espontánea y natural de respuesta. La inestabilidad reactiva se da, por ejemplo, después de intervenciones quirúrgicas, separaciones, disociaciones familiares, etc.

En otros niños, la inestabilidad aparece relativamente aislada, sin deficiencias importantes en otros aspectos del desarrollo y sin que el equilibrio psicoafectivo parezca perturbado. El nivel intelectual es normal. El problema depende del grado de tolerancia del ambiente, especialmente el familiar, frente a este tipo de comportamiento. Es probable que ciertos niños presenten de manera congénita una motricidad más «explosiva» que otros. En este caso, la respuesta intolerante del medio o unas exigencias excesivas pueden ocasionar la fijación de la reacción motriz en un estado patológico, determinando de algún modo una forma peculiar de ser: la inestabilidad.

En ocasiones esta inestabilidad se asocia con otras manifestaciones psicopatológicas: enuresis, alteraciones del sueño, dificultades escolares, conductas agresivas con reacciones de altanería, conductas provocadoras y temerarias, notable susceptibilidad y tendencia a la destrucción o a la autodestrucción. A veces el niño intenta castigarse o lograr que se le castigue.

La inestabilidad en estos casos puede adoptar el significado de una búsqueda de autocastigo como se observa en niños que experimentan un sentimiento de culpabilidad neurótica. En otros casos, la inestabilidad representa la respuesta a una angustia permanente, sobre todo cuando predominan los mecanismos proyectivos persecutorios o un equivalente a la defensa maníaca frente a angustias depresivas o de abandono.

La inestabilidad psicomotriz es ante todo un síntoma y, como tal, puede observarse en diversas estructuras psicopatológicas. Si se exceptúa la posibilidad de una experiencia depresiva subyacente, en la que la inestabilidad está incluida como defensa contra la depresión (v. pág. 359), en numerosos casos este síntoma parece integrarse en una estructura psicopatológica de tipo prepsicótico (v. pág. 396) o disarmonía evolutiva (v. pág. 399).

■ **Desde un punto de vista familiar,** en estos niños inestables se observa a menudo una constelación peculiar: madre muy apegada a su hijo, si bien esta proximidad puede enmascarar fantasmas agresivos o de muerte; padre distante, descalificado por la madre o que se descalifica a sí mismo en la relación con su hijo, en ocasiones, con una agresividad hacia el niño, expresada rudamente, al que percibe como un rival directo en relación con la madre (Ch. Flavigny).

■ La **respuesta terapéutica** frente a este niño inestable, para él y para su familia, no puede ser unívoca. Estará en función de la reacción del ambiente a la inestabilidad, reacción que puede ir desde el castigo o la franca coacción hasta la complacencia o la provocación.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito

Puede depender de la existencia o no de trastornos asociados (fracaso escolar, enuresis, etc.) o de la profundidad de los trastornos de personalidad. La acción terapéutica puede, pues, orientarse sea hacia una reorganización educativa (consejos educativos a los padres y a la escuela, práctica de un deporte o centro recreativo), sea hacia un intento de catexis libidinal positiva del conjunto corporal estático (relajación) o dinámico (diversos juegos psicomotores, danza rítmica), sea hacia una búsqueda de solución de los conflictos psicoafectivos (psicoterapia).

Para terminar, asociamos la «inestabilidad psicomotriz» con lo que los autores anglosajones denominan «niño hipercinético» y, en la actualidad, los «trastornos por déficit de atención» como se describen en el DSM-IV*. Para una discusión de este síndrome, véase la página 402.

VI. Tics

Los tics se caracterizan por la ejecución frecuente e imperiosa, involuntaria y absurda, de movimientos repetidos que representan a menudo una «caricatura del acto natural» (Charcot). Su ejecución puede ir precedida de una necesidad, y su represión suele ser causa de malestar. La voluntad o la distracción pueden detenerlos temporalmente. Desaparecen habitualmente en el transcurso del sueño.

Los tics faciales son los más frecuentes: parpadeo, fruncimiento de cejas, rictus, protrusión de la lengua, movimiento de la barbilla, etc. A nivel del cuello se observan tics de cabeceo, salutación, negación, rotación; citaremos también los tics de encogimiento de hombros, de los brazos, las manos, los dedos y finalmente los respiratorios (resoplar, bostezar, sonarse, toser, soplar, etc.) o fonatorios (chasquear la lengua, gruñir, gritos más o menos articulados, ladridos).

Todos estos tics pueden presentarse solos o asociados, manifestarse siempre idénticos en un mismo paciente o suceder unos a otros. Suelen aparecer entre los 6-7 años y se instauran lentamente. Antes de que sobrevenga el tic, el sujeto percibe una sensación de tensión y el tic aparece como una especie de descarga que le alivia. No es raro que la vergüenza o el sentimiento de culpabilidad acompañen al tic, sentimiento que puede verse reforzado por la actitud del entorno.

Hay que distinguir los tics de otros movimientos anormales que no poseen ni su brusquedad ni su aspecto estereotipado: movimientos coreicos, gestos conjuradores de obsesiones graves (frotarse los pies

*DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Masson, Barcelona, 1995.

sobre la estera, tocar preventivamente un objeto, etc.), estereotipia psicótica (caracterizada por la fineza y lo extraño del gesto), ritmias diversas (de los miembros o de la cabeza) que son menos bruscas.

Su evolución permite distinguir:

- **Tics transitorios:** pasajeros, que pueden relacionarse con ciertos hábitos nerviosos. Desaparecen espontáneamente. Son evidentemente los más frecuentes.

- **Tics crónicos:** afectación duradera, que acompaña a una organización neurótica.

- La **significación** del tic no es unívoca. Forma parte de estas conductas desviadas que se instauran en un estadio evolutivo del niño y cuya persistencia puede servir de punto de partida para múltiples conflictos ulteriores, adoptando así significaciones sucesivas, hasta perder lentamente su/sus significado(s) inicial(es) y convertirse en una forma de ser profundamente anclada en el soma.

Al principio, el tic puede ser una simple conducta motriz reactiva a una situación de ansiedad pasajera (con ocasión de una enfermedad, separación, etc.). Expresa, sin embargo, la facilidad con que algunos niños traspasan al ámbito motriz los afectos, conflictos y tensiones psíquicas. Su asociación con la inestabilidad es, por demás, frecuente. Ante esta facilidad, se concibe que el tic pueda convertirse en una vía privilegiada de descarga tensional.

Es frecuente la conjunción de tics y de rasgos obsesivos. Se trata de niños que se controlan mediante una gran vigilancia, que reprimen activamente una agresividad cuya intensidad puede ser hereditaria o bien resultado de situaciones reales traumatizantes. El tic adquiere entonces una significación directamente agresiva, mediante una tosca simbolización, o autopunitiva al dirigir la agresividad hacia sí mismo. El contacto con este tipo de niño «ticoso» es con frecuencia difícil y hasta distante. Raramente el niño evoca su síntoma con espontaneidad y en ocasiones incluso lo niega. Aparentemente sumiso y pasivo, esta pasividad enmascara en realidad una fuerte oposición. No es raro que sus dibujos sean perfeccionistas y rigurosos; los tics aparecen en forma de salvas e interrumpen su controlado grafismo.

En otros casos, el tic alcanza un significado más directo de conversión histérica. Se observa sobre todo en niños mayores o adolescentes; los tics sobrevienen entonces después de accidentes o intervenciones quirúrgicas.

Sea cual sea el significado psicodinámico para el propio niño, la respuesta del medio y, sobre todo, de los padres ante las primeras manifestaciones de los tics puede determinar su evolución. Avisos insistentes, burlas, prohibiciones, etc., pueden acrecentar la ansiedad o la angustia vinculándola directamente a las descargas motrices. Estas úl-

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito

timas, así asociadas a las imágenes paternas, conllevarán por tanto la carga libidinal o agresiva unida a ellas. De esta forma salta a la superficie la organización neurótica. El tic sirve a la vez para reforzar el conflicto y para descargar la tensión pulsional permitiendo evacuar el retorno de lo reprimido. La significación simbólica del tic será evidentemente variable para cada niño, según sean sus propias líneas de desarrollo y sus propios puntos conflictivos.

A un nivel más arcaico, el tic puede presentarse en niños con trastornos graves de la personalidad evocando organizaciones de tipo psicótico. En este caso, su significación puede ser la de la descarga pulsional directa en un cuerpo cuya percepción desmembrada resulta tan cercana que debe estar siempre controlada y bajo tensión.

■ **Actitud terapéutica:** la mayor parte de los medicamentos psicotropos no resultan o son muy poco eficaces, excepción hecha de las butirofenonas, cuya posología actúa de forma muy variada en uno u otro paciente.

En el plano familiar, es necesario que la ansiedad frente a dicho síntoma y las distintas reacciones que suscita puedan ser comprendidas, reconocidas y apaciguadas, si deseamos que se sigan los consejos dados (no dar importancia a los tics, no reprimirlos ni sobrevalorarlos).

En cuanto al niño, el enfoque terapéutico depende a la vez de los trastornos psicopatológicos asociados y del papel que los tics sigan desempeñando. Según esto, podemos proponer:

1. Terapia psicomotriz o relajación cuando el tic tiene un significado esencialmente reactivo y lleva asociado un comportamiento motor compuesto de inestabilidad o de torpeza.
2. Psicoterapia si el síntoma se da en el seno de una organización neurótica o psicótica que le confiere significación y que el propio tic refuerza.
3. Terapia conductual, tipo «inmersión» o «descondicionamiento operante» (p. ej., se pide al paciente que ejecute voluntariamente, frente a un espejo, el tic durante media hora todos los días o días alternos) cuando el síntoma parece ser ya un hábito motriz que ha perdido su significado original.

Sea cual fuere la terapia, cierto número de niños, a pesar de mejorar, conservan sus tics y se convierten en adultos ticosos.

■ **Trastorno de La Tourette**. Individualizada con este nombre en el DSM-IV, la enfermedad de Gilles de la Tourette se caracteriza por la asociación de:

1. Numerosos tics, recidivantes, repetitivos y rápidos localizados frecuentemente en la cara y extremidades superiores.

2. Múltiples tics vocales en forma de coprolalia (onomatomanía reiterativa de frases relativas a obscenidades), ecolalia (repetición en eco de las palabras del interlocutor), gruñidos, resoplidos, ladridos, etc.

La enfermedad, de inicio a los 2-15 años de edad, tiene una larga evolución (1 año o más). La intensidad de los tics es variable y en parte depende del contexto. El paciente puede suprimir voluntariamente los tics durante varios minutos o algunas horas.

Algunos investigadores han descrito, asociada a estas manifestaciones, una serie de anomalías neurológicas «menores» (hiperreactividad, signos neurológicos menores y anomalías inespecíficas del EEG).

Este conjunto sindrómico es poco frecuente; los tics motores pueden existir aisladamente sin los tics vocales y, en estos casos, el proceso se denomina «enfermedad de los tics» (Guinon), que debe ser distinguida de la enfermedad de Gilles de la Tourette propiamente dicha.

Se han suscitado numerosas discusiones etiopatológicas, actualizadas por el centenario de la primera descripción de la enfermedad (1885). Clásicamente considerada una forma neurótica peculiar, incluida en el marco de la psicopatología obsesiva, algunos investigadores han sugerido una etiología lesional (a nivel de los neurotransmisores) debido a las discretas alteraciones observadas y a la eficacia de algunos psicotropos (butirofenona, pimocide y clonacepam). No obstante, hoy en día, los resultados contradictorios de los estudios bioquímicos no permiten «una explicación bioquímica consistente del síndrome» (Dugas). Por el contrario, la evolución ocasionalmente favorable del paciente después de ciertas psicoterapias consistentes en la recuperación y revelación del sentido de los diversos tics respaldaría un origen neurótico o preneurótico, *borderline* (Lébovici y cols).

VII. Tricotilomanía. Onicofagia

La **tricotilomanía** caracteriza la necesidad más o menos irresistible de enrollar, acariciar, estirar o arrancarse los cabellos. Pueden aparecer grandes zonas peladas cuando los cabellos se arrancan a manojos. En algunos casos, el niño se come sus pelos y provoca un tricobezoar. Si bien el significado de este síntoma no es unívoco, los autores insisten tanto en el aspecto autoerótico (caricia, autoestimulación del cuero cabelludo, etc.) como en el aspecto autoagresivo. Esta conducta puede aparecer además en situaciones de frustración o de carencia: separación de los padres, muerte de uno de ellos, nacimiento de un bebé, ingreso en una institución, etc. y no ser otra cosa

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

que una más de las conductas desviadas en el seno de un cuadro más amplio.

Más frecuente todavía es la **onicofagia**, dado que según algunos autores se da en un 10 a un 30 % de los niños. Dicho comportamiento, además, persiste en numerosos adultos. Aun cuando no se pueda describir un tipo psicológico de niño onicofágico, sí podemos decir que, con frecuencia, se trata de sujetos ansiosos, vivos, activos y autoritarios. No son infrecuentes otros rasgos de conducta desviada: inestabilidad psicomotriz, enuresis, etc.

Aun cuando el niño no manifieste ningún tipo de incomodidad si es pequeño, al aumentar de edad, especialmente al alcanzar la adolescencia, puede incluso experimentar desagrado, un sentimiento de viva vergüenza acompañando a la onicofagia; prevalece entonces el prejuicio estético.

En el plano teórico, algunos ven en esta conducta un desplazamiento autoerótico que asocia el placer de la succión y un equivalente masturbatorio, muy directo, con una connotación autoagresiva y punitiva, tanto por las lesiones provocadas como por la respuesta desaprobadora del entorno. Es posible, además, que la reacción de ansiedad, interdictiva o agresiva de los padres ante las primeras tentativas de onicofagia del niño provoque en este último una fijación en dicha conducta, que adquiere entonces significación neurótica.

BIBLIOGRAFÍA

AJURIAGUERRA (J. DE), STAMBAK (M.) : L'évolution des syncinésies chez l'enfant. *Presse médicale*, 1955, *39*, p. 817-819.

AJURIAGUERRA (J. DE), BONVALOT-SOUBIRAN (G.) : Indications et techniques de rééducation psychomotrice en psychiatrie infantile. *Psychiat. enfant.*, 1959, *2* (2), p. 423-494.

AJURIAGUERRA (J. DE), HECAEN (H.), ANGELERGUES (R.) : Les apraxies. Variétés cliniques et latéralisation lésionnelle. *Rev. neurol.*, 1960, *1*, p. 566-595.

AJURIAGUERRA (J. DE), AUZIAS (M.), COUMES (I.), DENNER (A.).

AUZIAS (M.) : Enfants gauchers, enfants droitiers. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1975, 1 vol., 246 p.

AUZIAS (M.) : Les troubles de l'écriture chez l'enfant. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1981, 1 vol., 2e éd.

LAVONDES-MONOD (V.), PERRON (R.), STAMBAK (M.) : *L'écriture de l'enfant.* Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1964, 2 vol.

BERGES (J.), LÉZINE (I.) : *Test d'imitation de gestes. Technique d'exploration du schéma corporel et des praxies chez l'enfant de 3 à 6 ans.* Masson et Cie, Paris, 1963, 1 vol., 128 p.

DALERY (J.), MAILLET (J.), VILLARD (R. de) : Les tics de l'enfant. *Neuropsychiat. de l'enf.*, 1980, *28* (12), p. 581-585.

DUGAS M. : Le Syndrome de Gilles de La Tourette. Etat actuel de la maladie des tics. *Presse Med.*, 1985, 14, 589-593.

DUPRÉ (E.) : *Pathologie de l'émotivité et de l'imagination.* Payot, Paris, 1925.